# Hechos, inferencias e incertidumbre

## Metacognición, lenguaje y decisión clínica — dossier para prólogo

**Autor:** Daniel Opazo · **Género:** ensayo médico-epistemológico con herramientas aplicadas · **Extensión:** ~53.600 palabras (158 páginas A4 en manuscrito; 18 capítulos, 16 figuras) · **Estado:** edición de trabajo revisada, 2026 · **Público:** médicos clínicos y residentes; legible por todo profesional de la salud.

### La tesis en tres frases

El conocimiento clínico está compuesto por hechos incompletos, inferencias graduadas e incertidumbre irreductible. La inteligencia médica consiste en distinguirlos, integrarlos y decidir sin convertir la probabilidad en certeza. El lenguaje clínico —la frase de la ficha, la presentación en el pase de visita— es el instrumento donde esa distinción se conserva o se destruye.

### Qué lo diferencia

- **Es operativo, no contemplativo.** Cada capítulo termina en herramienta: un léxico de certeza con usos correctos e incorrectos, el método HII-D (hechos–inferencias–incertidumbre–decisión, con versión de 60 segundos), 18 talleres que reescriben notas clínicas reales, una guía de implementación para servicios.
- **Está centrado en la escritura clínica**, un ángulo que Groopman, Croskerry y la literatura de sesgos no cubren: la evolución, la epicrisis y el pase de turno como tecnología del pensamiento colectivo.
- **Toma posición en los debates vivos** — declara explícitamente su lugar en la controversia Croskerry vs. Norman/Monteiro sobre si puede enseñarse a "pensar mejor", y fundamenta los umbrales de decisión en el riesgo inductivo (Rudner, Douglas).
- **Modela lo que predica:** presenta HII-D como heurística no validada, formula qué evidencia obligaría a abandonarlo, y declara el uso de asistencia de IA en su elaboración.
- **Un caso longitudinal** (una paciente con obstrucciones intestinales recurrentes) atraviesa el libro completo, del ingreso a la decisión compartida, y un cuaderno de ocho viñetas —de la urgencia a las 3 AM al final de la vida— aplica el método.
- **Escrito en español desde la práctica hispanoamericana**, no traducido.

### Índice condensado

- **Parte I. Las capas del conocimiento clínico** — el hecho y su procedencia; la inferencia abductiva; la taxonomía de la incertidumbre; lenguaje y densidad epistémica.
- **Parte II. La mente que se observa** — metacognición y calibración; pericia e intuición (con el saber hacer de Varela); error como trayectoria (con un error del autor analizado); cuándo desacelerar, en qué estado y con qué mente.
- **Parte III. Decidir en el tiempo y con otros** — la evidencia leída y traducida al caso singular; umbrales, valores y bioética; temporalidad y contrafactuales; la ficha como instrumento de pensamiento (de resultados y de proceso); equipos, desacuerdo y comunicación de incertidumbre.

- **Parte IV. Una epistemología operativa** — humildad epistémica y responsabilidad (pensar bien como ética primordial); el método HII-D y su falsabilidad; cuaderno de ocho casos; enseñar y organizar la metacognición clínica; la inteligencia artificial en el proceso clínico (roles, riesgos y defensas); y un cierre desde la poesía chilena: Huidobro y Parra como los dos polos de la palabra clínica.
- Apéndices: hoja HII-D · léxico de certeza · guía de implementación en servicio · glosario · índice analítico · ~158 referencias (de Peirce, Polanyi y Maturana a Fleming, Mamede y los ensayos sobre IA clínica).

## Qué se solicita

Un prólogo de **800 a 1.200 palabras**, con **plazo flexible dentro de seis semanas** y **libertad total de contenido**, crítica incluida. El manuscrito completo se envía de inmediato a quien acepte considerar la invitación. Nombre del prologuista en portada e interiores.

**Contacto:** Daniel Opazo — [correo] — [teléfono]